

Übungsprogramm – Fuß und Sprunggelenk

Mobile Physiotherapie Grausam · Individuell abgestimmt auf Ihr Beschwerdebild

Akute Schmerzbehandlung

– Kühlung und Hochlagerung (RICE)

Ausgangsposition: Rückenlage oder Sitzen, betroffener Fuß über Herzhöhe gelagert.

Bewegung: Eispackung (in Tuch eingewickelt) für 10–15 Minuten auf die schmerzende Stelle legen. Fuß hochlagern.

Wofür: Reduziert Schwellung und akute Entzündungsreaktion durch verbesserten venösen Abfluss.

Tipp: Kühlung nie direkt auf die Haut – immer ein Tuch dazwischen. Nicht länger als 20 Minuten am Stück.

– Fußsohlen-Massage mit Tennisball

Ausgangsposition: Sitzen, Tennisball unter dem betroffenen Fuß.

Bewegung: Den Ball langsam über die gesamte Fußsohle rollen, an druckschmerzhaften Stellen kurz verweilen (5–10 Sek.).

Wofür: Löst Verspannungen der Plantarfaszie, verbessert lokale Durchblutung und lindert Fersenschmerzen.

Tipp: Morgens vor dem ersten Aufstehen besonders wirksam – 2 Minuten pro Fuß.

2–3 × täglich, je nach Schmerzintensität.

Mobilisationsübungen

– Sprunggelenk-Kreisen (aktiv)

Ausgangsposition: Sitzen oder Rückenlage, das Bein leicht angehoben.

Bewegung: Den Fuß langsam in großen, kontrollierten Kreisen bewegen – erst im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn. Je 10 Wiederholungen.

Wofür: Verbessert die Beweglichkeit des Sprunggelenks in alle Richtungen, regt die Gelenkflüssigkeit (Synovia) an.

Tipp: So große Kreise wie möglich, aber ohne Schmerz.

– Zehenstrecker und -beuger (aktiv)

Ausgangsposition: Sitzen, Fuß entspannt auf dem Boden.

Bewegung: Alle Zehen gleichzeitig so weit wie möglich hochziehen (strecken), kurz halten, dann wie eine Faust einrollen. Variante: nur die Großzehe heben, die anderen unten lassen.

Wofür: Aktiviert die intrinsische Fußmuskulatur und verbessert die Kontrolle über das Fußgewölbe.

Tipp: Wer Schwierigkeiten hat, Zehen einzeln zu steuern – das ist normal und kommt mit regelmäßiger Übung.

2 Sätze à 10–15 Wiederholungen pro Übung und Seite.

Stabilitätsübungen

– Einbeinstand (progressiv gesteigert)

Ausgangsposition: Stand, Stuhllehne oder Wand als Sicherung in Reichweite.

Bewegung: Auf einem Bein stehen, Knie leicht gebeugt. Beginn: 20–30 Sekunden mit offenen Augen. Steigerung: Augen schließen, dann auf einem Kissen stehen.

Wofür: Trainiert die Tiefensensibilität (Propriozeption) des Sprunggelenks – essenziell zur Rückfallprävention nach Verletzungen.

Tipp: Das leichte Wackeln des Fußes ist der Trainingseffekt – nicht unterdrücken.

– Zehengang und Fersengang

Ausgangsposition: Stand, aufrechte Körperhaltung.

Bewegung: 10 Schritte auf den Zehenspitzen gehen (Waden aktiv), dann 10 Schritte auf den Fersen gehen (Zehenstrecker aktiv). Abwechseln.

Wofür: Kräftigt die gesamte Unterschenkelmuskulatur und verbessert die dynamische Stabilität des Fußes.

Tipp: Langsam und kontrolliert – Fußsohlenkontakt mit dem Boden bewusst spüren.

2–3 Sätze à 30 Sekunden (Einbeinstand) · 2 × 10 Schritte (Zehengang).

Kraftübungen

– Wadenheben einbeinig (Calf Raise)

Ausgangsposition: Stand auf dem betroffenen Bein, Zehenspitzen leicht auf einer Stufe oder Erhöhung.

Bewegung: Langsam auf die Zehenspitzen heben (2 Sek. hoch), kurz oben halten, dann kontrolliert und langsam absenken (3–4 Sekunden). Die Absenkphase besonders betonen.

Wofür: Stärkt Gastrocnemius und Soleus – die wichtigsten Stabilisatoren des Sprunggelenks.

Tipp: Einbeinig noch zu schwer? Zweibeinigen beginnen. Die langsame Absenkphase ist wichtiger als das Hochheben.

– Kurzfußübung (Short Foot Exercise)

Ausgangsposition: Sitzen oder Stand, Fuß flach auf dem Boden, Ferse und Ballen haben Bodenkontakt.

Bewegung: Das Längsgewölbe des Fußes anheben, ohne die Zehen zu krallen – Ferse und Ballen bleiben am Boden.

Wofür: Aktiviert die intrinsische Fußmuskulatur (M. abductor hallucis) – wirksam bei Spreizfuß und Plantarfasziitis.

Tipp: Sehr subtile Bewegung – ein Stück Papier unter das Gewölbe legen und versuchen es festzuhalten hilft beim Erlernen.

– Fußheber gegen Theraband (Dorsalextension)

Ausgangsposition: Sitzen, Theraband um den Fußrücken geschlungen, Band am Stuhlbein befestigt.

Bewegung: Den Fuß gegen den Widerstand nach oben ziehen (Zehen Richtung Schienbein), kurz halten, kontrolliert zurück.

Wofür: Kräftigt die Tibialismuskulatur und verhindert ein unkontrolliertes Umknicken nach vorne.

Tipp: Widerstand moderat wählen – Kontrolle vor Intensität.

3 Sätze à 12–15 Wiederholungen. Pause: 60 Sekunden zwischen den Sätzen.

Allgemeine Hinweise

- Übungen 3–4 × pro Woche ausführen.
- Bei akuten Schmerzen: nur Kühlung und Hochlagerung – keine Kraft- oder Stabilitätsübungen.
- Schmerzen während der Übung sind ein Warnsignal – Intensität reduzieren.
- Bei anhaltenden Beschwerden über 5–7 Tage bitte Rücksprache mit dem Therapeuten.
- Besonders empfehlenswert nach langen Geh- oder Stehbelastungen.